

7. 뇌전증 지속증 (간질 중첩증)

- 경련이 30분 이상 지속되거나, 반복되는 발작 사이에 의식의 회복이 완전하지 않은 경우

- **원인★** : 3세 미만에서 가장 흔한 원인은 열성경련

① 특발성 : 항경련제 중단 및 불규칙한 복용

② 증후성 : 뇌질환, 전해질 이상, 저혈당증, 약물중독

- **치료 목표★**

① 가능한 빠른 시간에 발작을 중지시켜, 발작자체에 의한 뇌손상을 줄임

② 장시간 지속되는 발작으로 인한 저산소증, 산증, 저혈압에 의한 2차적 손상을 줄임

8. 뇌전증 유사 질환

: 뇌전증으로 오인하여 불필요한 항경련제 치료를 하지 않도록 주의해야 함

① 호흡정지발작	(1) 청색증형	● 야단 맞거나, 화가 나서 심하게 울다가 호흡중지 ● 청색증, 의식소실, 서맥 발생, 사지의 간대경련, 각궁반장 ● 6개월 이전에 드뭄 2세 전후에 호발 5세 이후에 소실
	(2) 창백형	● 다치거나 갑자기 심하게 놀랐을 때 발생 ● 강직발작, 서맥
② 실신발작	(1) 혈관 미주신경성 실신 (simple syncope)	● 혈관미주신경 반응에 의한 일시적인 혈압저하로 뇌혈류량 감소 ● 오랫동안 서있거나 통증, 분노 등에 유발 ● 의식소실, 강직성 근수축 동반 10~12세 이전은 드뭄 (사춘기 여아多) ● 진단 결과 : 뇌파검사 정상, 기립경검사 기립경 검사 : 기립경사검사는 실신이나 실신에 가까운 어지러움의 원인이 자율신경계통에 있는지 재현을 통해 질환을 판정하기 위한 검사 (거꾸리에 태워서 증상이 나타나는지를 관찰하는...) - 양성
	(2) Cough syncope	● 발작적 기침 → 흉강 내 압력 상승 → 정맥환류 감소 → 좌심실 심박출량 감소 → 의식소실, 안면홍조, 발한, 근이완, 간대성 근수축 ● 대개 잠이 든 후 발작적 기침과 함께 의식소실이 나타남
③ 야경증		• 소아가 잠든 후에 곧 매우 긴장하여 잠에서 깨는 것 • 말을 거의 안 함 주위 사람들을 알아보지 못함 몸부리치고, 쉽게 진정X • 1/3에서 몽유병 동반 동공확대, 빠른 맥, 과다호흡

④ 분노발작	• 사소한 자극에도 행동을 조절하지 못하고, 차거나 할퀴는 등의 거친 행동을 반복
⑤ 가성발작	- 10~18세 여아 발작 중 신음 및 우는 경우 多, 외부로부터의 자극에 쉽게 반응 (→ 타인이 소리치면 발작 심해지고, 멈추라고 하면 발작이 괜찮아짐) - 청색증X 발작 중 혀를 깨물거나 다치는 경우 X 동공반사, 팔약근 기능 정상
⑥ 기면발작	• 낮 동안 억제할 수 없는 잠이 발작적으로 반복됨 (소아에서는 드뭄) • 간질과 달리, 쉽게 잠에서 깨어날 수 있음 의식소실X

9. 치료

- 치료 목적: 뇌전증 발작을 완전히 조절하거나 빈도를 감소시켜서 환자의 신체적 및 사회적 안녕이 저해되지 않도록 하는 것
- 이전에 건강하던 소아가 처음 비열성 발작을 한 경우, 가족력이 없고 신경학적 검사와 뇌파가 정상 이라면, 항경련제 치료를 일반적으로 보류함
- 항경련제 치료를 할 경우 부작용이 나타날 가능성이 30% 정도이므로 첫 번째 발작이 특별 전신 간 대 발작으로 생각되고 뇌파가 정상인 소아는 치료를 시작하지 않지만 1년 이내에 2회 이상의 긴장 간대 발작이 있으면 치료가 필요함

3절. 뇌성마비

- 한의학 : 오연(五軟), 오경(五硬) 에 해당
- 조기 뇌 발달 장애로 인하여 발생하는 여러 **운동 증후군** : 진행성 질환 (X) / 정체성 질환 (O)
- 원인 : 발달장애, **유전**, 대사이상, 허혈, 감염 등

1. 증상

- ① 발달장애 흔히 동반 : 지능장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 인지장애, 행동장애, 간질 등 포함
 - ② 뇌의 발달은 4세에 완료 → 극심한 경우를 제외하고는, 신생아기에 발현X
 - ③ 4개월부터 뇌성마비 의심 가능
 - ④ 아동이 성장함에 따라 증상이 발현 : 나이에 비해 운동발달이 늦거나, 신생아 반사의 이상을 보임 → 그러다가 좀 더 자라면 강직성과 무력성을 구분할 정도가 됨
- # 4개월 정상아 : 모로반사, 움켜잡기 반사 소실 | 보행반사(walking reflex, stepping reflex)가 명확하게 나타남

2. 분류

① 강직 편마비	- 마비된 쪽의 자발적인 움직임 감소 팔 > 다리 (일찍부터 한쪽 손만 사용하는 경향) - 특징 증상 : 회전보행 마비된 손과 엄지손톱의 성장장애 동반 근긴장력 증가 → 발의 청내반족 기형 환자의 1/3은 경련질환을 가지고 있음 (보통 2세 내에 증상이 나타남) - 뇌 전산화단층 촬영(CT)에서 대뇌의 위축과 마비된 사지의 반대편(=정상) 기저핵 확장이 발견됨
② 강직성 하지마비	- 영아가 기기 시작할 때, 포복자세로 힘을 쓰지만 다리가 끌려감 - 걸음이 늦게 시작되고, 걷더라도 발끝으로 걷게 됨 - 증상 : 심한 양하지 강직 강력한 근반사 바빈스키 반사 양성 Ankle clonus 관찰 - 아기의 양 겨드랑이를 들어올리면, 다리가 가위모양으로 엇갈림 - 걸음은 늦게 시작되고, 걷더라도 발끝으로 걷는 점이 특징
③ 강직성 사지마비	- 가장 중증 중증의 정신지체, 간질, 연하곤란증, 언어장애, 시각장애 동반 - 사지의 강직성 마비와 강력한 심부건반사가 무릎과 팔꿈치에 병발
④ 아테로이드형 뇌성마비	- 비교적 빈도는 낮음 출생 시 질식과 연관多 1세가 되어야 발현O - 증상 : 무력증 (목 가눌 수 없고, 수유가 불편하고, 혀가 나오며 침을 많이 흘림) 구음장애, 언어장애 지능은 대부분 정상

3. 대운동기능분류체계 (GMFCS)

- Gross Motor Function Classification System
- 뇌성마비 아동의 대근육 운동기능을 평가하는 분류체계
- 특히 스스로 앉거나 걷기, 휠체어를 사용하여 이동하기 등을 5단계로 분류하는 체계
- 각 단계는 아동의 기능적인 능력, 보조장비의 필요성, 일부 움직임의 질적 상태 등을 나타냄
- 단계 분류를 통해 현재 아동의 기능적 상태와 대근육 운동기능 중 부족한 부분을 표현하도록 함
- 뇌성마비 아동이 할 수 있는 것뿐 아니라 집이나 학교, 지역사회에서 실제로 수행할 수 있는 것이 무엇인지 기록
- 아동의 운동능력은 나이에 따라 다름 → GMFCS의 5단계 분류체계는 2세 이하, 2~4세, 4~6세, 6세, 12세, 12~18세로 구분하여 사용

1단계	제한 없이 독립 보행이 가능한 경우
2단계	독립 보행은 가능하지만 장거리 보행은 제한이 있으며 달리기와 제자리 뛰기는 어렵다
3단계	스스로 앉을 수 있으며, 실내에서 지팡이를 이용하여 보행이 가능하며, 실외 이동을 위해서는 수동 휠체어를 사용하기도 한다
4단계	보통 지지대에 의지하여 앉으며, 스스로의 움직임이 제한되고 대부분 이동에서 수동 혹은 전동 휠체어를 사용한다
5단계	목과 체간 조절에 상당한 제한이 있으며, 전동 휠체어 사용법을 배울 수 있다면 스스로 이동이 가능하기도 하다

4. 진단

- 출생 후나 영아시에 발병 | 비진행성 | 유전이 원인X
- 방사선 검사, 뇌자기공명영상(MRI)에서 뇌위축, 뇌내공동이 보이거나 기형이 보임

5. 예후

- ① 예후 좋음 : 지능이 정상 + 운동장애 심함
- ② 예후 나쁨 : 지능장애와 운동장애 모두 심함 | 잦은 경기로 뇌에 산소부족
- ③ 보행 가능성 : 편마비형, 운동실조형 O | 강직형, 저긴장형 X

4 절. 퇴행 뇌질환

- 주요 특징 : 진행성 뇌질환 | 습득하였던 언어, 시력, 청력, 운동기능 등이 점차적으로 퇴행

① 신경원성 세로이드 리포푸신증 (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)	- 정의 : 유전적인 lysosomal storage 질환 뇌회질 변성 자가형광지질색소인 세로이드와 리포푸신이 세포 내에 과다 축적 → <u>신경세포를 죽이고, 뇌를 위축시킨다</u> - 임상 경과 : 망막 변성으로 시력장애 및 실명, 근간대성 경련, 운동실조, 지능퇴행, 구음장애
② Krabbe 병 ★	- 정의 : 상염색체 열성으로 유전하는, 백질의 퇴행성 질환 - 증상 (a) 초기 증상 : 심하게 울고 보챔, 구토, 수유장애, 체중이 늘지X (→ 위장관 질환으로 오인가능) (b) 진행시 증상 : 전신성 경련 발작, 강직성 사지마비, 청력 상실, 대개 2세 전에 사망
③ Rett 증후군	- 정의 : X 염색체 우성으로 유전하는 퇴행성 신경 질환 (→ 여아에서만 나타남) - 특징 : 생후 6~12개월까지는 정상 발달, 이후 발달이 퇴행하고 뇌가 자라지 않아 후천적 소두증 - 증상 : 양손을 비비며 손을 씻는 모양의 운동 (6~30개월 특징), 언어의 퇴행, 보행실조, 손의 미세한 진전, 자폐적 행동, 간헐적 과호흡, 불규칙한 호흡 양상

5 절. 중추신경계 발달 이상

1. 수두증

정의	뇌척수액이 과량으로 저류 → 뇌실계가 확대, 뇌압이 항진된 상태
임상 증상	① 두위가 비정상적으로 큼, 봉합이 넓은, 대천문 확대 ② 대천문 부위를 두드리면 깨진 항아리 소리 ③ 이마가 얼굴보다 돌출되고, 안구는 밑으로 내려옴 (=下疳(하찬)) ④ 뇌의 위축 진행 → 사지의 강직성 변화, 운동정신발달의 지연 2세 이전 : 두개골 봉합의 폐쇄 아직 X 2세 이후 : 구토, 기면, 경련 등 비특이적 뇌압상승 증상 + 수두증을 유발한 원인 질환에 의한 국소성 신경증상

2. 피부신경 증후군

- 중추신경계와 피부는 외배엽에서 기원 → 피부증상이 신경계의 이상과 동반되어 나타남

1) 신경성유종증 제1형

- 신경 피부질환 중 가장 빈도가 높은 질환, 상염색체 우성으로 유전
- 증상 : 밀크커피색 반점, 홍채의 Lisch 소결절, 다발신경성유종, 정신발달 지연 (10%)

2) 결절 경화증

- 뇌의 결절과 뇌실막 밑에 신경 세포의 숫자는 감소하고 과다증식된 성상세포와 크고 다핵의 기형적인 세포로 구성된 경화된 결절 관찰
- 3징후 : 경련 | 지능장애 | 피지샘종
- 피부소견 : 출생 시 또는 영아기에 다양한 크기의 흰색 점이 몸통과 사지에 나타남 | 4~6세에 피지샘종 (처음엔 코, 뺨에 작고 붉은 구진의 여드름 모양의 다발성 발진 → 크기, 숫자가 증가하고 합쳐짐)
- 중추신경증상 : 여러 형태의 간질발작이 나타남

6절. 중추신경계 감염질환

1. 세균성 수막염

1) 신생아 수막염

- 일반 증상 : 호흡곤란, 구토, 설사, 복부팽만, 수유곤란, 체온변화
- 신경학적 증상 : 기면, 대천문 팽윤, 국소성 또는 전신성 비특이적 경련, 경부강직 등

2) 신생아기 이후의 급성 화농성 수막염

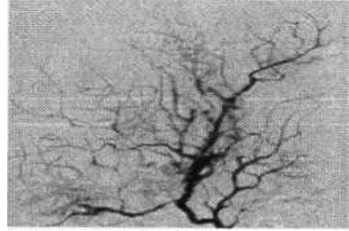
- 상기도 or 소화기 증상 후 수일간 지속되는 발열 + 기면, 보챔과 같은 중추신경계 감염 증상을 보임
- 뇌막자극은 경부강직, 요통, kernig sign과 Brudzinski sign으로 나타남
진단을 위한 검사 : 경부강직, Kernig 검사, Brudzinski 검사 ★

2. 바이러스 수막뇌염

원인	• 장바이러스(enterovirus) : 가장 흔한 원인 • 주로 여름, 가을에 발생 / 사람과 사람 사이로 전파 / 4~6일의 잠복기
초기 증상	① 연장아 : 두통, 지각과민 ② 영유아 : 보채거나 다루기 힘들, 두통 (전두측 or 전체적) ③ 사춘기 : 구후동통, 발열, 구역, 구토, 목이나 등, 다리의 동통, 광선공포증
치료	• 세균 감염을 배제할 때까지 항생제 투여를 시행
예후	• 대부분은 완전히 회복되거나, 뇌실질이 관여되면 예후 나쁨 • 2세 미만 환자 중 10%는 급성 합병증 (경련, 뇌압상승, 혼수)을 경험하나 신경학적 예후는 좋음

7절. 뇌혈관 질환

1. 모야모야병

증상	• 다양한 신경증상, 두통을 동반한 상부운동신경정후, 경련, 무도증이 반복적으로 나타남
원인	• 정확한 원인X / 내경동맥의 supraclinoid portion, 중대뇌동맥, 전대뇌동맥의 근위부가 좁아지거나 막혀 발생
진단	 뇌동맥조영술상 뇌혈관의 협착과 폐색이 온 혈관 주위에 작은 혈관들이 발달되어 → 안개갈고, 연기가 피어오르는 듯한 소견을 기저핵에서 관찰O
치료	• 혈관 재생술을 시도 • 손상받은 부위에서의 뇌관류는 일어나지 않으나, 주위 경계부를 포함한 허혈 대뇌피질은 혈류가 개선되고, 특히 일과성 허혈발작은 90% 정도에서 사라짐

2. 뇌동정맥기형

증상	• 편두통 호소, 50%에서 두개골 청진상 고음의 잡음 • 파열되면 심한 두통, 목의 경축, 구토, 점진적인 편마비 발작
원인	• 발생 시기에 동맥과 정맥 사이에서 정상적인 capillary bed가 형성되지 않아서 발생함
치료	• 수술로 제거 가능

8절. 두부외상

1. 경미한 두부 외상

- 깊은 상처가 없고 의식 소실의 이력이 없는 두부 외상의 경우 대개는 특별한 검사나 입원이 필요하지 않음
- 경미한 두부 외상 후 24~48시간까지는 현기증, 오심, 구토, 두통이 생길 수 있지만 상당한 정도의 또는 진행성의 기면을 동반하지 않는다면 별 문제가 되지 않음
- 간혹 두 개 내 출혈이 동반되는 경우가 있으므로 밤에 한 번은 환자를 깨워 환자가 깨는지 확인 (수면 중 의식수준이 저하되는 것을 확인)

2. 뇌진탕

- 두부 외상 후 의식소실이 동반된 경우
- 뇌의 병리학적 변화X & 뇌간의 일시적 기능 장애 상태 → 의식 소실 기간 길지 않음
- 역행성 기억상실증 & 전향성 기억상실증이 나타날 수 있음
- 의식 소실기간 및 역행성 기억 상실의 정도가 두부외상의 정도와 상관관계 有

3. 두개골 골절

- 두개골 방사선 촬영상의 골절은 충격의 위치를 아는데 도움이 되지만, 뇌손상의 정도를 나타내지 않음
- 골절이 있는 경우 두개내 출혈을 염두에 두어야 함
- 단순한 선상 골절은 특별한 치료를 요하지 않음
- 단, 함몰 골절은 아주 경미한 경우가 아니면 수술로 경막 결손 부위를 막아주어야 함
- 영아에서 두개골 골절 후 수개월 또는 수년 경과하면서 골절선이 넓어져 두개골 결손부가 생기는 수가 있음

9절. 한의학 병증

1. 경풍

- 소아 특유병증 중 하나로 광범위한 경련성 질환을 총칭 (∴ 소아기 중추신경계의 불완전한 발달로 인해)
- 불완전한 발달로 인해 중추신경 질환의 증상뿐 아니라 모든 전신적 변화(감정, 식체 등)에 대해 쉽게 경련으로 반응
- 1~5세에서 많음 | 抽搐(추축), 意識不清이 특징적으로 나타남

• 구분

- 1) ① 급경풍 : 경풍 자체가 급작스러운 열성경련, 각종 뇌막염, 뇌염, 뇌부종 등 감염으로 인한 경련 | 병세가 급함
→ 병세가 급하고, 힘이 있고, 병의 부위는 심간 (일반적으로 열성경련을 말함)
- 2) ② 만경풍 : 전해질 및 대사장애로 인한 경련, 테타니 등 | 병세가 완만함
→ 병세가 완만하고, 힘이 없고, 병의 부위는 비위
- 3) ③ 만비풍 : 만경풍보다 비허가 더 심하여 脾虛肝旺된 상태 | 음증이 매우 심한 상태

	급경풍	만경풍	만비풍
발병 형태	폭급	완만	완만
발작 경과	비교적 짧다	비교적 길다	길다
정신 상태	不清	不清 혹은 尙清	不清 혹은 似清非清
경련	아주 격렬	미약 혹은 다소 극렬	약함
발열	고열, 돌열한 체온상승	低熱 혹은 無熱	無熱 혹은 體溫不升
담명(痰鳴)	항상 있음	있거나 없음	없음
설질	紅, 絳 ¹⁾	淡紅 혹은 絳	淡白 혹은 暗晦
설태	白膩, 黃, 乾	白滑, 灰黑 혹은 乾	白滑 혹은 灰黑
맥상	數, 有力	細數, 無力	細沈微弱
속성, 형증(形證)	실, 열, 양, 유어	허, 한, 음허, 양허, 부족	純陰無陽
치법	응급처치 후 변증시치	培補元氣, 溫運脾胃	大補脾土, 益胃回陽
예후	다양	비교적 나쁨	나쁨

- 경풍의 특징

4증 : 급경풍 시 나타나는 증후	분류	증상	치법	치방
	경증 (심)	神識不清, 昏睡不醒, 瞻語驚叫, 恐懼不安	안신진 경	청열진경탕, 안신진 경환, 우황청심원
	풍증 (간)	牙關緊急, 口味不開, 角弓反張, 口角牽引, 手足播揚, 頸項強直, 身體顫動, 眼目竄視	식풍개 규	지보단
	담증 (비)	咳嗽氣促, 痰涎壅盛, 滿口痰濁, 喉間痰鳴, 神志不清或昏迷	척담공 하	우황환
	열증 (폐)	高熱眼紅, 脣頰發赤, 口中氣然, 喜歡飲冷, 小便黃渾, 手足抽搐, 神昏譫語	청열식 풍	양격산

8후 : 抽搐(추축)의 임상표현			
搐 (경련할 축)	팔꿈치를 오므리고 폈다 반복	反 (뒤집을 반)	몸이 펴지고 머리가 뒤를 향함
搦 (잡을 닌)	손가락을 쥐었다 폈다 반복	引 (끌 인)	손을 활 쏘 때처럼 오므리며 당김
掣 (당길 철)	어깨와 머리가 서로 끌어당기는 모양	竄 (숨을 찬)	눈이 화난 것처럼 위를 향함
顫 (떨릴 전)	온몸을 흔들	視 (볼 시)	좌우 살피는 것처럼 안구불안정

1) 급경풍

변증	증상	치법	치방
1) 풍한형 ★ (대부분)	외감풍한으로 인한, 인후가 붓는 경우 多, 만 2~3세 전 多 (과정 : 풍한 → 풍열 → 열극생풍 → 간풍내동)	소풍청 열 좌이진 경	연교패독산, 가미향소산, 선방패독탕, 담성탕
2) 식결형 ★	유식적체로 인한, 반복경련이 많아 간질로 오인 가능, 4~5세 多 (과정 : 유식정체장위 → 울구화열 → 열심 격동간풍)	소식도 체 좌이진 경	곽향정기산, 향시평위산, 성향산
3) 경공형	폭수경공으로 인해 전신경련보다는 부분적 경련 (팔다리 多) 밤에 깜짝 놀라서 우는 현상, 악몽을 꾸고 잠 깨대	진경안 신	귀비온담탕
4) 온열형	온사 → 화열화화 → 열극 격동간풍 *온역병 (전염병) : 유행성 이하선염, 홍역에 병발되는 뇌염	청열해 독	연교패독산
5) 감수서사	여름의 더위가 원인	-	신가향유음 가미

2) 만경풍

변증	증상	치법	치방
1) 비허간왕 ★	의식이 또렷하지 X 嗜臥露睛 (눅기 좋아하고 눈동자 드러남) 사지불온, 대변당박, 면색위황/광백 설담태백, 맥침세무력	온온비양 부토억 목	완간이비탕, 성비탕, 전씨백출산
2) 비신양허	대천문 함몰 혼수불성 수족전동(떨림) 이마에 땀 사지궤냉, 면색광백 설담백활, 맥침세무력	온보비 신 회양구 역	고진탕, 가미이중탕
3) 간시음허	간헐적 강직성 추축 음허내열, 허번, 조홍, 도한 면색광백, 대변건조 설광부태, 설담건, 맥세삭	육음보 양 자수함 목	대정풍주, 육미지황탕, 자음강화탕, 자음건비탕
4) 협열협담	신열 갈증 흉중창만, 호흡이 거칠다 가래를 토함	부정거 사 청화담 열	청심척담탕

3) 만비풍

- 만경풍에서 비허가 더 심하여 비허간황된 상태 (비신양허보다 한증이 더 심한 상태)

4) 경풍 처치

- 경풍 발작 시, 옆으로 눕혀 구토물과 담액이 호흡기를 막지 않도록 함
- 서늘하고 바람이 잘 통하는 곳에 옮기고, 미온수로 하열시킴
- 推搡(추촉) 시, 억지로 약을 먹이지 않고 L-tube를 통해 약물/음식물을 공급함
- 병이 호전되면 단백질이 풍부한 음식을 공급함
- 경련 발작시 십선혈, 사봉혈, 백회, 인중, 용천 등을 자침하여 순기행혈

2. 간증

변증	증상	치법	치방
1) 음간	안색청백, 사지궤냉 구토연말 맥상침세 지문이 뚜렷X 옆드려서 경련	치법은 어디에도 언급X (기출 예도, 개정 전 교과서 예도)	輕) 성비탕, 정간단 甚) 고진탕, 오생환
2) 양간	얼굴이 붉고 누워있기 좋아함 신열자한 구토연말 손발경련 아관긴급 맥상홍대		용담탕, 사청환, 포룡환, 용뇌안신환
3) 경간 ★	안색이 붉었다 하얗다가 함 토설 심신불안 여인장포 맥상 홀대홀소		가미온담탕, 청담보신탕
4) 담간 ★	담연옹성 구토담말 호흡이 급박하고 졸도 맥현활		온담탕, 청담탕, 가미이진탕
5) 식간 ★	면색발황 복창 토사산취 심와부 중완부 압통 위장이 부어있음		곽향정기산, 향사평위산, 자상환
6) 풍간	면색홍적, 눈동자 푸름 인사불성 열손가락 경련 맥부삭		輕, 有汗) 화풍단 重, 無汗) 강활계지탕 痰) 우황환, 가미강활탕

간증의 처치

- 인두 점액을 닦거나 흡인하고, 머리를 옆으로 돌려 침이나 토사물이 기도으로 넘어가지 않게 함
- 외상 받지 않도록 주위의 위험한 물건을 제거함
- 고열이 있을 때는 머리를 식히고, 미온수로 몸을 닦고 해열제 사용
- 발작이 일어나는 중에는 기계적 접촉이나 억누르려는 행동X

3. 오지 오연 오경

1) 오지

변증	증상	치법	치방
1) 간신후손	치아가 늦게까지 나지 않음 똑바로 서있지 못함	보신양간	육미지황환, 육미지황탕
2) 심기부족	의사표현을 단어로만 하고, 문장 구성X 운동발달, 언어가 늦음	익심기 통신규 양심혈	창포환, 귀비탕
3) 기혈허약	肌膚蒼白, 精神不振, 疲倦乏力, 頭髮稀少萎黃	보익기혈 자양신음	보영십전탕, 보중익기탕

2) 오연

- 뇌성마비 중 아데토이드 뇌성마비

3) 오경

- 뇌성마비 중 강직성 마비 (강직성 편마비, 강직성 하지마비, 강직성 사지마비)

변증	증상	치법	치방
1) 한사응고★	四肢冷, 僵硬不能起, 皮膚色暗發紫, 面色晦暗, 脣舌暗紅	온경통락	당귀사역탕, 소속명탕, 오약순기산
2) 비양허약★	體質虛弱, 身冷, 僵臥少動, 昏昏多睡, 氣息微弱, 哭聲低弱無力, 局部皮膚硬直麻木	익기온양	삼부탕, 십전대보탕가미, 육군자탕

4. 신헌 신진

1) 신헌 : 대천문 함몰 (6개월 이내 유아에서 천문이 약간 함몰되어 있는건 병X)

2) 신헌 : 대천문 융기

5. 해로

- 태아가 출생 후 두개골 사이의 골봉과 천문이 닫히지 않은 것 (=수두증)
- 병인 : 선천부족의 신헌, 후천실조의 비허, 수열, 담열, 풍열, 음사

변증	증상	치법	치방
1) 신키후손	천문부 팽대 두피 빛남 머리가 크고 목은 가늘며, 머리가 기울고 목을 가누지 못함 청근목로, 신체수척, 발육지연, 지능저하	보신키수	보신키황환, 육미지황환, 팔물탕, 십전대보탕, 가감지황탕
2) 신헌간항★	근척육손, 계종 신변불안, 수족심열 구설홍, 맥침세삭	지신키음 평간식 풍	지백지황탕 합 삼갑복맥탕, 육미지황환
3) 비허수범★	눈 흰자위 많고 광채X 신헌이 정체됨 식욕부진, 면색광백, 대변희당, 대변불리	부비리수	부자이중탕 합 오령산
4) 열독응체	두통구건 발열기축 면적순홍 대변건비 소변단적 맥현삭	청열통락	화독단